

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE PERSONALIDAD PARA EL DSM-5 (PID-5)

Eje III: Personalidad • Modelo Alternativo Dimensional de Trastornos de la Personalidad (AMPD)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Personalidad para el DSM-5 (PID-5: 220 reactivos).
Nombre Original	The Personality Inventory for DSM-5 (PID-5; Krueger et al., 2012).
Autores Originales	Dr. Robert F. Krueger, Patrick K. Derringer, David Watson y Andrew E. Skodol (APA).
Adaptación Hispana	Versión oficial española de la APA; Gutiérrez et al. (2017), España.
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad Disfuncional. Criterio B del AMPD: 5 dominios y 25 facetas desadaptativas.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 220 reactivos con escala Likert de 4 puntos (0 a 3).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (desde 16 años). Ámbito clínico ambulatorio y psiquiátrico.
Tiempo de Administración	25 a 40 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto por la American Psychiatric Association para uso clínico y de investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO HÍBRIDO ALTERNATIVO DEL DSM-5 (SECCIÓN III)

El **Inventario de Personalidad para el DSM-5** (PID-5; Krueger et al., 2012) fue creado por el Grupo de Trabajo de Personalidad y Trastornos de la Personalidad del DSM-5 para operacionalizar el **Criterio B del Modelo Alternativo para Trastornos de la Personalidad** (AMPD, Sección III). Frente al modelo categorial clásico de 10 trastornos estancos (Sección II), el AMPD adopta un enfoque dimensional jerárquico que evalúa el desajuste de la personalidad como variantes extremas y maladaptativas de los rasgos normales.

El modelo comprende 5 dominios de orden superior y 25 facetas específicas de rasgo patológico:

- Afecto Negativo (vs. Estabilidad Emocional):** Labilidad afectiva, ansiedad, sumisión, inseguridad por separación y hostilidad.
- Desapego (vs. Extraversión):** Retraimiento social, evitación de la intimidad, anhedonia y afectividad restringida.
- Antagonismo (vs. Cordialidad):** Manipulación deliberada, falsedad, grandiosidad, búsqueda de atención e insensibilidad.
- Desinhibición (vs. Responsabilidad):** Irresponsabilidad, impulsividad, distraibilidad, temeridad y desorganización.
- Psicoticismo (vs. Lucidez):** Creencias y experiencias inusuales, excentricidad y desregulación perceptiva cognitiva.

3. DISTRIBUCIÓN DE LAS 25 FACETAS EN LOS 5 DOMINIOS DESADAPTATIVOS

Dominio Desadaptativo	Facetas Específicas Incluidas	Enfoque Psicopatológico Central
1. Afecto Negativo	Labilidad, Ansiedad, Inseguridad, Sumisión, Hostilidad	Reactividad ansiosa, pánico vincular y sufrimiento interno crónico.
2. Desapego	Retraimiento, Evitación de intimidad, Anhedonia, Frialidad	Aislamiento social voluntario, desapego afectivo e incapacidad hedónica.
3. Antagonismo	Manipulación, Falsedad, Grandiosidad, Insensibilidad	Egocentrismo hostil, deshonestidad instrumental y falta de empatía.
4. Desinhibición	Irresponsabilidad, Impulsividad, Distraibilidad, Temeridad	Búsqueda de gratificación inmediata sin previsión de consecuencias.
5. Psicoticismo	Creencias inusuales, Excentricidad, Desregulación cognitiva	Pensamiento cuasi-delirante, experiencias perceptivas discordantes.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en la validación española de Gutiérrez et al. (2017; N = 824 clínicos y comunitarios): alfa de Cronbach entre 0.86 y 0.94 para los 5 dominios y entre 0.72 y 0.91 para las 25 facetas; coeficientes omega > 0.88. Estabilidad test-retest r = 0.86 a 4 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora la estructura jerárquica de 25 facetas subordinadas a los 5 grandes dominios desadaptativos (CFI = 0.92, TLI = 0.91, RMSEA = 0.048).
Validez Concurrente	Elevada concordancia diagnóstica con entrevistas estructuradas (SCID-5-PD, r = 0.65 a 0.78). Correlación con el NEO-PI-R en sus polos invertidos y con el BSL-23 en gravedad límite.
Diagnóstico Híbrido de TP	Permite derivar los 6 trastornos de la personalidad específicos del AMPD (Límite, Obsesivo-Compulsivo, Evitativo, Esquizoide, Narcisista y Antisocial) mediante algoritmos de facetas.
Invarianza de Medida	Invarianza métrica demostrada entre muestras de pacientes ambulatorios psiquiátricos y población general.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 220 reactivos se califica en una escala Likert de 4 alternativas (0 a 3):

- **Opciones de Puntuación:** 0 = «Muy falso o a menudo falso», 1 = «A veces o algo falso», 2 = «A veces o algo verdadero», 3 = «Muy verdadero o a menudo verdadero».
- **Paso 1 (Inversión de Ítems Inversos):** En el PID-5 original no existen ítems inversos complejos (excepto en facetas específicas como Perfeccionismo Rígido según guía oficial de la APA).
- **Paso 2 (Medias por Faceta y Dominio):** Se suman las puntuaciones de los reactivos de cada faceta y se divide entre el número de reactivos que la componen:

$$\text{Media de Faceta} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \text{Ítem}_i$$

(Rango: **0.00 a 3.00 puntos**).

- **Puntuación de Dominio:** Se promedian las facetas que integran cada uno de los 5 dominios.

6. BAREMOS NORMATIVOS Y PUNTOS DE CORTE CLINIMÉTRICO (MEDIAS 0.00 A 3.00)

Estratificación	Media Dimensional	Nivel de Rasgo	Interpretación y Significación Clínica
Asintomático	0.00 a 0.79 pts	Rasgo no adaptativo ausente	Funcionamiento adaptativo normalizado en ese ámbito de la personalidad.
Subclínico	0.80 a 1.49 pts	Rasgo moderado / Situacional	Dificultades circunscritas bajo estrés agudo sin constituir trastorno consolidado.
Clínico / Elevado	1.50 a 2.19 pts	Rasgo desadaptativo clínicamente significativo	Interferencia manifiesta en relaciones o área laboral. Cumple Criterio B para TP.
Severo / Extremo	2.20 a 3.00 pts	Rasgo extremo (>= 2.20)	Patrón desadaptativo rígido, perverso y de alto riesgo destructivo interpersonal.

CRITERIO CLÍNICO: PERFIL DE TRASTORNO LÍMITE (AMPD DSM-5):

Se confirma el diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad cuando la media es **>= 1.50** en al menos 4 de las 7 facetas características: Labilidad Emocional, Ansiedad, Inseguridad de Separación, Depresividad, Impulsividad, Temeridad y Hostilidad.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA BASADO EN EL PERFIL DE RASGOS PID-5

PROTOCOLO DE ABORDAJE MODULAR DE PERSONALIDAD DISFUNCIONAL:

- **Paso 1 (Mapeo de Dominios Elevados):** Identificar qué dominios superan la media de 1.50. Si domina Afecto Negativo + Desinhibición, priorizar Terapia Dialéctica Conductual (DBT). Si domina Antagonismo + Desapego, aplicar Terapia Basada en la Mentalización (MBT) o Terapia de Esquemas.
- **Paso 2 (Contención de la Impulsividad y Riesgo):** Si la faceta de Temeridad o Impulsividad supera 2.00, diseñar un plan de contingencia contra autolesiones o consumo de tóxicos.
- **Paso 3 (Reestructuración de Creencias de Antagonismo/Desapego):** En presencia de Hostilidad o Desconfianza, trabajar la relación terapéutica colaborativa para desactivar la paranoia vincular.
- **Paso 4 (Monitorización Longitudinal):** Un descenso en las facetas patológicas a < 1.20 consolida la estabilidad adaptativa.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DESREGULACIÓN AFECTIVA Y PATOLOGÍA LÍMITE

Identificación: Mujer de 23 años, estudiante universitaria, derivada por el servicio de urgencias tras una intoxicación medicamentosa impulsiva con benzodiacepinas tras una discusión telefónica con su pareja.

Evaluación Inicial PID-5 (Línea Base): Perfil típico de Trastorno Límite: **Labilidad Emocional = 2.75/3.00; Inseguridad de Separación = 2.80/3.00; Ansiedad = 2.60/3.00; Impulsividad = 2.50/3.00; Hostilidad = 2.20/3.00.** Dominios Afecto Negativo (2.35) y Desinhibición (2.10) en rango severo.

Plan Terapéutico: 20 sesiones de Terapia Dialéctica Conductual (DBT) individual y entrenamiento en habilidades grupales (tolerancia al malestar, mindfulness y regulación emocional). Se acordó un protocolo explícito de llamada previa a cualquier crisis autolesiva.

Reevaluación a los 6 Meses: Impulsividad descendió a **1.10/3.00; Inseguridad de Separación a 1.35/3.00; Labilidad a 1.40/3.00.** Cesaron por completo las conductas de parasuicidio y la paciente concluyó su curso académico con estabilidad emocional.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

TEMERIDAD ELEVADA Y RIESGO AUTOLÍTICO:

Una puntuación en Temeridad e Impulsividad ≥ 2.20 combinada con Depresividad elevada predice actos suicidas no planificados y conductas autolesivas letales (aplicar C-SSRS).

PSICOTICISMO VS. PSICOSIS CLÍNICA:

El dominio de Psicoticismo evalúa esquizotipia rasgo (ideas mágicas, excentricidad). Diferenciar de brote psicótico franco con delirios estructurados fijos y alucinaciones activas.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D., & Skodol, A. E. (2012). Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. *Journal of Personality Disorders*, 26(6), 779-807.
2. Gutiérrez, F., et al. (2017). The Spanish version of the Personality Inventory for DSM-5 (PID-5): Psychometric properties. *Assessment*, 24(7), 897-911.
3. American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). APA.
4. Bach, B., et al. (2015). The DSM-5 alternative model for personality disorders. *Journal of Personality Assessment*, 97(1), 3-15.